PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Analgesia no esporte

Anti-inflamatórios, corticoides e o que a dor informa

Medicina Esportiva Clínica

COPA DO MUNDO DE 2010

Anti-inflamatório antes de cada partida



até 1 em 3

tomou anti-inflamatório antes de cada partida



mais da metade

usou durante o torneio

> Segundo as listas declaradas pelos médicos das seleções. O título do trabalho: “lição não aprendida”.

AS TRÊS DECISÕES DA AULA

Resolve, esconde, custa

Véspera de jogo

o lateral pede “o de sempre” para não sentir o tornozelo

Prova longa e força

o corredor toma ibuprofeno antes das duas

Três semanas para competir

a atleta com tendinopatia quer infiltrar

o que resolve · **o que esconde** · **o que custa**

Três perguntas antes de qualquer analgésico

O que dói, e por quê?

dor sem diagnóstico é dor sem plano

→

Há quanto tempo?

dor de sete semanas quase nunca se resolve com comprimido

→

O que muda se a dor sumir?

se ele vai treinar igual, a medicação não trata: permite

→



O anti-inflamatório de sempre: não

Sem racional

não previne lesão, não melhora desempenho, não protege articulação

Tira o sinal

sem o incômodo, ele entra na dividida em que não entraria



“o de sempre”

O cenário do rim

calor, desidratação e esforço máximo

O vestiário

quem entrega, o quê, em que dose, onde está escrito?

No lugar: examinar, ajustar carga, analgesia com diagnóstico e prazo, considerar a via tópica, registrar.

O QUE FAZER NO LUGAR

Paracetamol não é anti-inflamatório

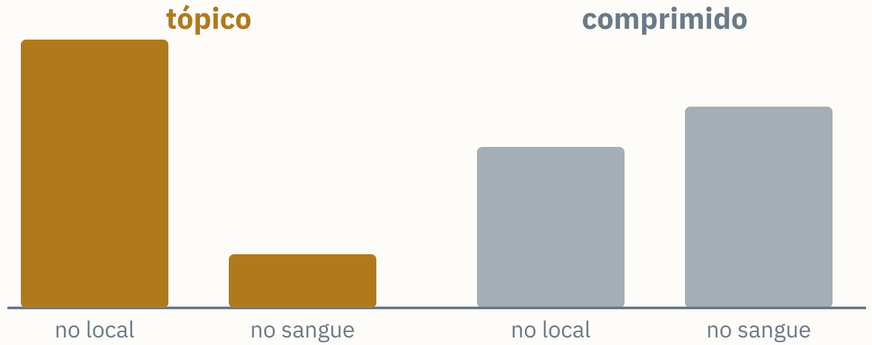
Analgesia com plano

1. examinar o que dói
2. ajustar a carga e tratar a causa
3. fármaco, dose, prazo, reavaliação
4. registrar quem prescreveu e até quando

A via tópica

esquema

dor superficial e localizada



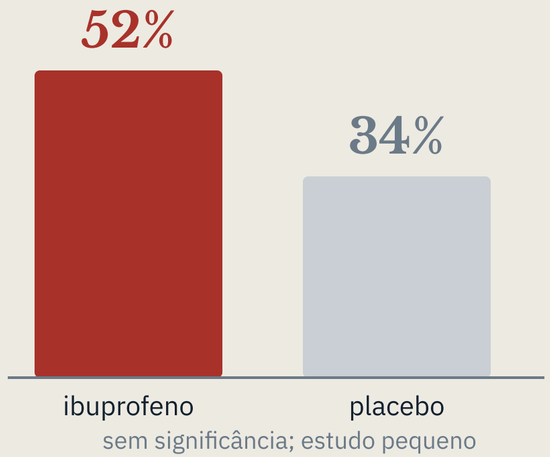
> Quem precisa só de analgesia nem sempre precisa de anti-inflamatório sistêmico.

Ultramaratona de 80 km, ibuprofeno contra placebo

44%

dos corredores com lesão renal aguda, no conjunto

ultramaratona de 80 km



sem significância; estudo pequeno

5,5 corredores tratados para causar um caso



a cada 11 tratados, 2 casos a mais

E ainda: estômago e perda de sangue, que levam à deficiência de ferro; hiponatremia; pressão no adulto mais velho; dose somada por nomes comerciais diferentes.

Ensaio randomizado, Emerg Med J 2017

Dois usos ruins, por razões diferentes

Antes da prova longa

esforço prolongado, calor, desidratação

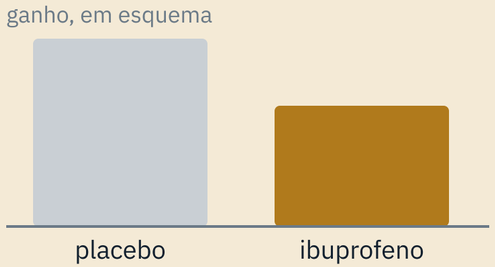
+ fluxo renal reduzido

+ risco no sódio

não é prevenção: é risco somado

Antes do treino de força

1.200 mg por dia, 8 semanas: menos ganho de força e de massa



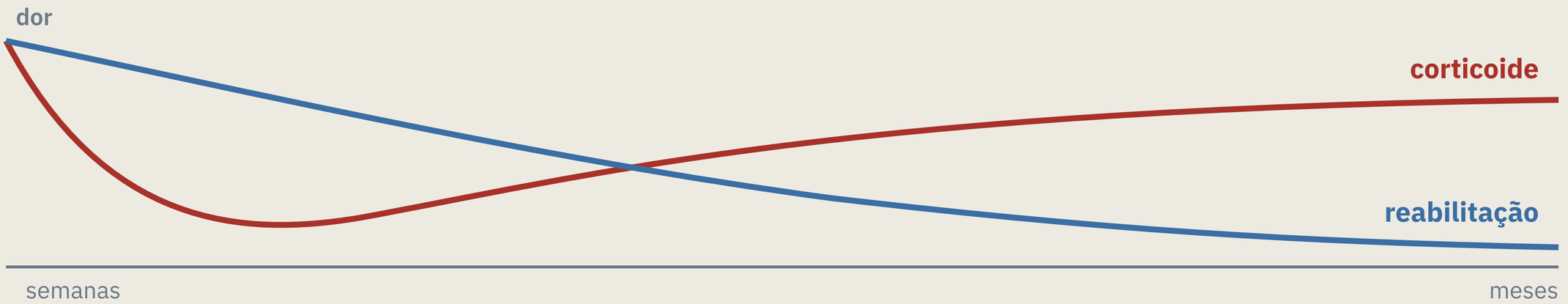
doses menores: efeito limitado

o alvo é o uso crônico e preventivo

> A inflamação depois do treino faz parte do sinal que produz adaptação. Dor recorrente pede técnica, calçado, progressão e força.

Ensaio randomizado em adultos jovens, Acta Physiol 2018

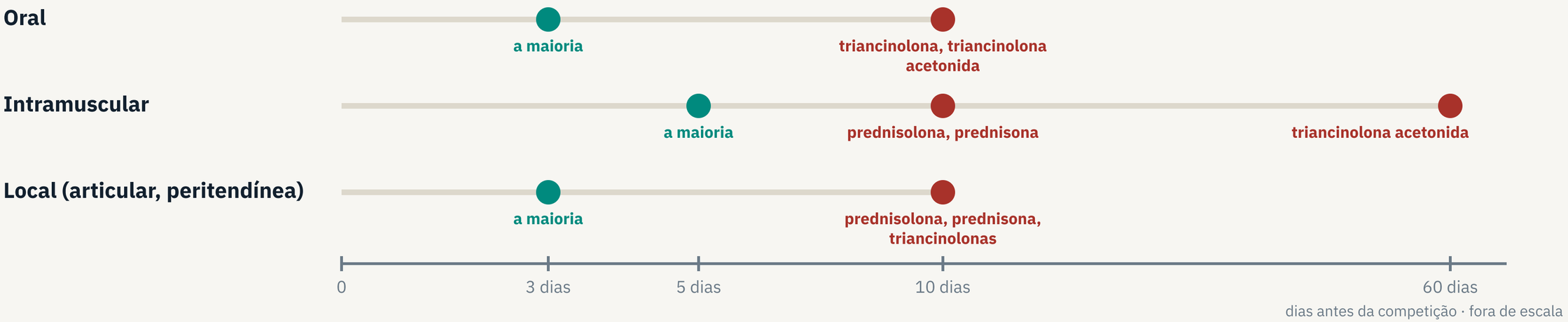
Alívio rápido, inversão depois



Superior no curto prazo, as outras condutas passam à frente no médio e longo prazo, e sinal de prejuízo com injeções repetidas.

Esquema, sem valores medidos · revisão sistemática, Lancet 2010

Os períodos de eliminação antes da competição



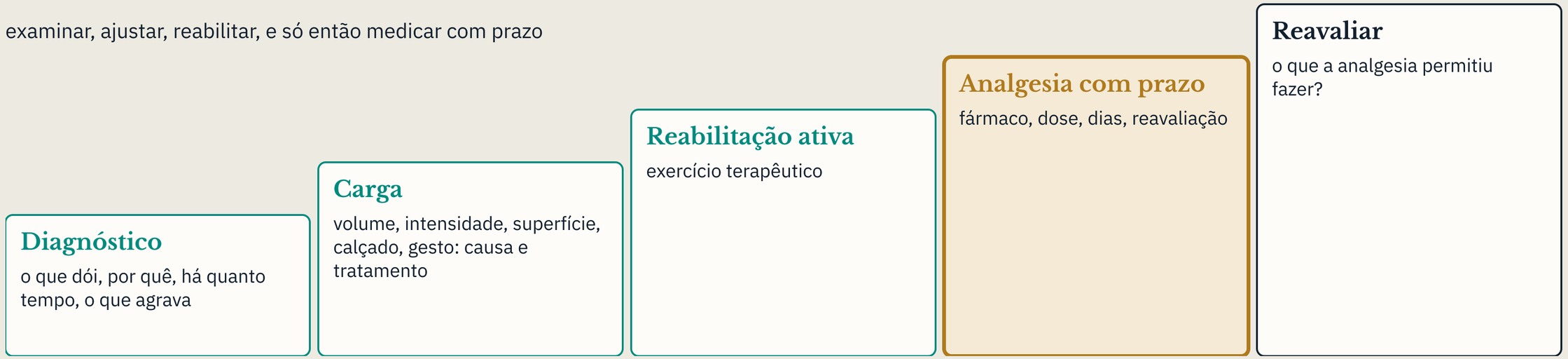
Proibidos em competição por via injetável, oral ou retal. Depósito pode ficar detectável além do prazo, e a lista muda: confira a vigente.

Lista de substâncias proibidas da WADA, 2026, S9

A ESCADA QUE SUBSTITUI O COMPRIMIDO REFLEXO

A analgesia fica no meio, não na base

examinar, ajustar, reabilitar, e só então medicar com prazo



PARA QUALQUER CLUBE OU ACADEMIA

Quatro perguntas de controle

- [ ] **Quem prescreve?**
  prescrição é médica, inclusive a do anti-inflamatório comum
- [ ] **Onde está registrado?**
  medicação, data, dose, responsável
- [ ] **Ele sabe o que toma?**
  o princípio ativo, não o comprimido branco
- [ ] **Há quanto tempo?**
  a pergunta que revela o uso crônico

> Analgésico sem data de término vira uso crônico por inércia.

AS TRÊS DECISÕES, RESPONDIDAS

Examinar, ajustar, reabilitar, e só então medicar com prazo

- Não existe anti-inflamatório profilático no esporte
- Dose alta crônica custa rim, estômago, ferro e adaptação
- Corticoide alivia rápido e pode custar depois; confira a eliminação

Médico

Prescreve fármaco, dose, via e prazo; decide infiltração.

Fisio e preparação

Exercício terapêutico; carga, técnica e material.

Todos

Não distribuem nem emprestam; registram e perguntam.

“Só um anti-inflamatório” continua sendo prescrição.